ERGE y úlcera péptica

FISIOPATOLOGIA · Clase 29 · reflujo, Barrett, agresores y defensores, úlceras y complicaciones

1 · EL ÁCIDO DIGESTIVO Y LA BARRERA

HCl gástrico F16
activa la pepsina y desnaturaliza las proteínas para liberar aminoácidos

es parte de una secreción diaria de

Secreciones digestivas F15
unos 9 L al día (saliva 1,5; gástrico 2,5; bilis 1,5; páncreas 1,5; intestino 1); solo ~100 ml salen en heces

solo daña si falla la barrera:

Dos barreras
en el esófago, el EEI; en estómago y duodeno, la mucosa con sus defensas

en el esófago la barrera es el

2 · ERGE: POR QUÉ SUBE EL ÁCIDO

EEI cerrado (barrera tónica) F3
gastrina, PG E2α, metoclopramida y cisaprida suben su presión; la progesterona la baja

si pierde tono produce

Más volumen o presión gástrica
obstrucción de la salida del estómago o hernia de hiato

empuja el contenido y produce

Más ácido producido
estados hipersecretores

desborda la barrera y produce

Reflujo gastroesofágico F21
sube ácido, pepsina y bilis por tres vías: tono del EEI, presión gástrica y producción de ácido

inflama el esófago y causa

Lesión de la mucosa
inflamación y cicatriz con retracción: círculo vicioso, el EEI queda menos competente

en estómago y duodeno la barrera son las

si persiste evoluciona a

puede volver sin esfuerzo como

3 · REFLUJO: CLÍNICA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

por la noche y tras comer da

Pirosis
ardor retroesternal que empeora acostado, tras comer o con fármacos

se estudia con

Interrogatorio y endoscopia
muestran hipotonía del EEI, hernia hiatal y complicaciones

si persiste la duda se pide

si llega a la faringe da

Regurgitación F22
el alimento vuelve a la boca sin náuseas ni vómito

Manifestaciones atípicas y de alarma
tos crónica, dolor torácico que imita un infarto, disfagia y odinofagia

si hay duda se confirma con

si hay duda se confirma con

detecta complicaciones como

pH-metría de 24 h F4 · F23
patrón oro si hay duda: el pH esofágico baja de 4

al confirmar el reflujo guía el

Tratamiento F5 · F6 · F12
ranitidina (anti-H2) y lansoprazol (IBP) bajan el ácido; hidróxido de aluminio lo neutraliza; la dieta láctea no

4 · COMPLICACIONES DE LA ERGE

Esofagitis péptica
inflamación del tercio inferior del esófago

cicatriza con fibrosis y causa

en el esquema del docente figura en

cambia el epitelio y forma el

Estenosis F27
fibrosis de úlceras: disfagia a sólidos y luego a líquidos; la endoscopia descarta Barrett

Esófago de Barrett F9 · F17
metaplasia intestinal (no displasia): la complicación más peligrosa

Esquema del docente F10
esofagitis, estenosis y Barrett con adenocarcinoma; la hemorragia no figura (literatura: sí puede)

predispone al

si se cierra del todo produce

Adenocarcinoma esofágico: riesgo del Barrett

Estenosis completa: impactación de alimentos

5 · ÚLCERA: AGRESORES CONTRA DEFENSORES

Defensas F11
moco, bicarbonato, prostaglandinas, uniones estrechas y ciclo celular rápido

si pesan menos que los agresores hay

H. pylori F1 · F18: primer agresor
15 % de los infectados hace úlcera; en más de la mitad de las úlceras; causa gastritis crónica y también úlcera duodenal

rompe la defensa y produce el

actúa alterando moco y subiendo el HCl

AINEs F2 · F7 · F8
bloquean las prostaglandinas: bajan moco y bicarbonato; la retrodifusión de H+ da gastritis aguda

quitan defensas y producen el

Estados hipersecretores F29
gastrinoma, mastocitosis, alcohol y estrés

suben el ácido y producen el

Cómo daña
altera moco y bicarbonato y sube el HCl

Desequilibrio
los agresores pesan más que las defensas

si es crónica puede llevar a

erosiona la mucosa y forma la

Gastritis atrófica F26
mueren las células parietales: sin ácido, gastrina elevada

Úlcera péptica
erosión que atraviesa la mucosa gástrica o duodenal

en la curvatura menor es la

6 · ÚLCERA DUODENAL Y GÁSTRICA

Úlcera duodenal F24
más del 90 % en el bulbo, en los primeros 3 cm tras el píloro; dolor urente 2-3 h tras comer, despierta de madrugada y calma con comida

en el bulbo duodenal es la

por ser benigna se trata como

Benigna: se trata el desequilibrio (antisecretores y erradicación de *H. pylori*)

Factores de riesgo
AINEs, tabaco, estrés, alcohol y *H. pylori*

predisponen a la

Úlcera gástrica F20
curvatura menor; pico a los 60 años; puede ser maligna

por su riesgo de cáncer se

Se biopsia para descartar cáncer

7 · COMPLICACIONES DE LA ÚLCERA

invade un órgano vecino y causa

cicatriza y estrecha: causa

Perforación F19
abre a la cavidad peritoneal: peritonitis química y luego bacteriana; neumoperitoneo en la Rx

sin cirugía produce

Peritonitis generalizada: fatal sin cirugía

erosiona un vaso y causa

Penetración
va a un órgano vecino: páncreas (duodenal) o lóbulo hepático izquierdo (gástrica)

a diferencia de la perforación queda

Queda contenida en el órgano vecino: no hay peritonitis libre

Síndrome pilórico F13 · F25
edema o cicatriz cierra el píloro; no hay estenosis cardial

por el vómito y la mala ingesta causa

Vómitos tras comer: desnutrición, deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico

Hemorragia digestiva alta F14
la más frecuente: hematemesis y melena; si es masiva, hipotensión, taquicardia y síncope

se ve en el

Caso F28
toma AINE, tiene melena y mareo al pararse: hemorragia por úlcera

si es masiva produce

Shock hipovolémico si la hemorragia es masiva

concepto · mecanismo · causa · síntoma · signo · diagnóstico · ejemplo · complicación · desenlace · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 34 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura)